政策法规文件中文译本合集

收录文件： 45 CFR 第92部分节选（ACA 第1557条实施条例）、医疗卫生领域 CLAS 国家标准（2025年6月修订版）
文件数量： 2 份
译文性质： 两份均为参考译文，不具法律效力，引用请以英文原文为准
生成日期： 2026年10月14日

合集说明

1. 本合集收录两份美国医疗卫生领域文件的中文参考译本，各自独立成篇，互不隶属，请勿互相援引。
2. **两份文件的法律效力不同，阅读时务必区分。**
3. **45 CFR 第92部分** 是依据《平价医疗法案》第1557条制定的联邦行政法规，**具有法律约束力**，文中"必须""须"对应原文的 `must` / `shall`。
4. **CLAS 国家标准** 是服务质量框架与推荐性标准，**本身不产生法律义务**；其中部分要求仅在特定情形下，经由其他法律（如1964年《民权法》第VI编）对接受联邦资助的机构间接产生约束。
5. 各篇开头的"译者说明"针对该篇专有术语与文本瑕疵，请一并阅读。
6. 45 CFR 第92部分的译文源文件为 PDF 转写节选，**首尾均不完整**，此处按原样译出，未作推测补全。

45 CFR 第92部分——健康项目与活动中的反歧视规定（节选）

§ 92.11 语言协助服务及辅助器材和服务可获得性的通知

子部分B——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视

医疗卫生领域文化与语言适宜服务（CLAS）国家标准

首要标准

治理、领导与员工队伍

沟通与语言协助

参与、持续改进与问责

45 CFR 第92部分——健康项目与活动中的反歧视规定（节选）

来源文件： CFR-2025-title45-vol1-sec92-11.md
法规出处： 美国联邦法规汇编（CFR）第45编第1卷，第92部分（45 CFR Part 92），即依据《平价医疗法案》（ACA）第1557条制定的实施条例
涉及条款： § 92.10（末段）、§ 92.11、子部分B（Subpart B）、§ 92.101
译文性质： 参考译文，不具法律效力，引用请以英文原文为准

> **译者说明**
>
> 1. 本译文的源文件为 PDF 转写的 Markdown 节选，**首尾均不完整**：正文自 § 92.10（a）（1）（ii）项起，至 § 92.101（b）（1）（i）项末尾一句处中断。此处按原样译出，未作补全推测。
> 2. 原文以 `recipient`、`covered entity` 等法律术语表述主体，中译分别处理为"受助方""受涵盖实体"，并在首次出现处保留英文原词。美国法语境下 `recipient` 指依联邦财政资助项目接受资助的机构，与中国法语境下的"受赠人"含义不同。
> 3. `title VI`、`title IX` 指美国法典与法案中的"编（章）"序，非"标题"；译作"第VI编""第IX编"以区别于"第六条""第九条"。
> 4. 原文中 `Dept. of Health and Human Services` 一行系 PDF 页眉，转写时被插入条款中间，非规范条文内容，译文一并保留并加注说明。
> 5. 本部分为具有法律约束力的联邦行政法规，"must""shall"等义务性表述译作"必须""须"；但本译文仅作理解参考。

（ii）在为使残障人士能够获得无障碍环境和平等参与机会确有必要时，为残障人士免费并及时提供的合格手语译员，以及盲文、大字印刷等替代格式的信息；

（iii）在语言协助服务构成使英语熟练程度有限的个人获得有意义服务机会的合理步骤时，受涵盖实体免费并及时提供的语言协助服务，包括电子和书面的翻译文件以及口头传译；

（iv）如何向受涵盖实体获取本节（a）（1）（ii）项和（iii）项所述的合理改造、适当辅助器材和服务以及语言协助服务；

（v）受涵盖实体依据第92.7节指定的第1557条协调员（Section 1557 Coordinator）的联系方式（如适用）；

（vi）受涵盖实体依据第92.8(c)节所设申诉程序的存在，以及提出申诉的方式（如适用）；

（vii）向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体方式；以及

（viii）如何访问受涵盖实体的网站（若有），以获取本（a）（1）段要求提供的信息。

（2）本（a）段要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

（i）每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

（ii）经请求时提供；

（iii）在受涵盖实体健康项目或活动网站（若有）的显著位置提供；以及

（iv）在清晰、显眼的实体场所提供，字体不小于20磅的无衬线字体，且该场所应属可合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知之处。

（b）受涵盖实体可将本（a）段要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 及 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清晰告知个人其依据第1557条和本部分享有的公民权利，且包含本（a）（1）段要求的各项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助器材和服务可获得性的通知

（a）受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器材和服务可获得性的通知，该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，在依据第1557条或本部分确有必要时，向该健康项目或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及社会公众，免费提供语言协助服务及适当辅助器材和服务。

（b）本（a）段要求的通知必须以英文，以及受涵盖实体开展业务所在相关州中英语熟练程度有限的个人最常使用的至少15种语言提供；并且必须以替代格式，向需要辅助器材和服务以确保有效沟通的残障人士提供。

（c）本（a）段要求的通知须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

（1）每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

（2）经请求时提供；

（3）在受涵盖实体健康项目或活动网站（若有）的显著位置提供；

（4）在清晰、显眼的实体场所提供，字体不小于20磅的无衬线字体，且该场所应属可合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知之处；以及

> 译注：此行系原 PDF 页眉，被转写脚本插入到条款列表中间，并非规范条文内容。此处未按章节标题处理，以免误读为条款。

（5）在受涵盖实体提供下列电子和书面文件的情形下，该通知应一并提供：

（i）第92.10节要求的反歧视通知；

（ii）45 CFR 164.520 要求的隐私做法通知；

（iii）申请表和受理登记表；

（iv）拒绝或终止资格、福利或服务的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉权和申诉权通知；

（v）涉及个人权利、资格、福利或服务，且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出答复的通信；

（vi）与突发公共卫生事件有关的通信；

（vii）与医疗程序或手术、医疗委托授权书（medical power of attorney）或生前预嘱（living will）有关的同意书和说明（可选择对合并在一起的所有文件仅提供一份通知）；

（viii）出院文件；

（ix）与个人医疗费用及支付有关的通信，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第2799B–6条要求的诚信估算（good faith estimates）；

（x）投诉表；以及

（xi）患者和会员手册。

（d）受涵盖实体如选择采取下列任一做法，则就该个人而言，视为符合本节规定：

（1）每年向该个人提供选择，使其可以选择不再接收以其主要语言并经任何适当辅助器材和服务提供的本节所要求通知，并且：

（i）不以该个人选择不再接收为条件，来决定是否提供任何补助或福利；

（ii）告知该个人，其有权经请求获得以主要语言并经适当辅助器材和服务提供的该通知；

（iii）告知该个人，选择不再接收该通知，并不构成放弃本部分所规定的获取语言协助服务和任何适当辅助器材和服务的权利；

（iv）每年以书面记录载明该个人已选择在该年度不再接收本节所要求的通知；以及

（v）不将个人未作答复视为选择不再接收；或

（2）记录该个人的主要语言及任何适当辅助器材和服务，并且：

（i）以该个人的主要语言并经任何适当辅助器材和服务提供所有材料和通信；或

（ii）在本（c）（5）段所列的所有通信中，以该个人的主要语言并经任何适当辅助器材和服务提供本（a）段所要求的通知。

子部分B——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视

（a）一般规定。（1）除《平价医疗法案》（ACA）第I编（title I）另有规定外，任何人不得因种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残障或上述各项的任何组合，而被排斥参与受涵盖实体运营的任何健康项目或活动、被拒绝享受其福利，或在其中受到其他形式的歧视。

（2）基于性别的歧视包括但不限于基于下列方面的歧视：

（i）生理性别特征，包括双性（intersex）特征；

（ii）怀孕或相关状况；

（iii）性取向；

（iv）性别认同；以及

（v）性别刻板印象。

（b）具体的禁止歧视规定。（1）在本部分适用的任何健康项目或活动中：

（i）受助方（recipient）和州交易平台（State Exchange）必须遵守本部为实施第VI编（title VI）、第504条（section 504）、第IX编（title IX）和《年龄歧视法》（Age Act）而制定的实施条例中关于禁止歧视的具体规定，分别见 45 CFR 第80部分、第84部分、第86部分（C、D子部分）和第91部分（B子部分）。凡本（b）段援引的、使用"受助方"（recipient）一词的监管条款——

> 译注：源文件在此处中断，原文后续内容缺失。

医疗卫生领域文化与语言适宜服务（CLAS）国家标准

来源文件： EnhancedNationalCLASStandards_Revised_June2025.md（《增强版 CLAS 国家标准》，2025年6月修订）

译文性质： 参考译文，不具法律效力；以美国卫生与公众服务部（HHS）发布的英文原版为准

> **译者说明**
>
> 1. CLAS（Culturally and Linguistically Appropriate Services）通译为"文化与语言适宜服务"；亦有"文化及语言适切服务""文化语言服务"等译法，本书名不作权威认定。
> 2. 这15项标准属于**服务质量框架与推荐性标准**，本身不构成联邦法律义务。其中部分要求（如提供语言协助）在特定情形下经由其他法律（如1964年《民权法》第VI编）对接受联邦资助的机构产生约束，但 CLAS 标准文本本身为倡导性指引，不直接产生法律责任。
> 3. 原文句中 `should be avoided and discouraged` 为建议性表述，译作"应避免和不鼓励"。

国家 CLAS 标准旨在促进健康、提高服务质量并帮助消除医疗服务差距，为此为医疗卫生及健康照护机构确立行动蓝图，使其：

首要标准

1. 提供有效、易懂且尊重服务对象的高质量照护与服务，并契合其在文化健康观念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求方面的需要。

治理、领导与员工队伍

2. 推进并维持组织治理与领导，使之通过政策、实践和资源配置来促进 CLAS。
3. 招募、晋升、培养并支持能够回应服务人群在数字化、文化和语言方面需求的治理层、领导层和员工队伍。
4. 定期就 CLAS 的实践与相关资源，对治理层、领导层和员工队伍开展教育培训。

沟通与语言协助

5. 向英语熟练程度有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以帮助其及时获得各项医疗照护与服务。
6. 以书面和口头方式告知所有个人可获取语言协助服务，并以英语及能够满足其语言需求的其他语言提供相关信息。
7. 通过培训和认证（在具备条件时），确保提供语言协助的人员具备胜任能力；同时应认识到，应避免和不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译。

8. 以服务区域内人群常用语言，提供通俗易懂的电子和印刷材料及标识标牌。

参与、持续改进与问责

9. 制定文化和语言适宜的目标、政策和管理问责机制，并将其贯穿于组织的各项规划与运营之中。
10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进工作的情况。
11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。
12. 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果规划和实施契合服务区域内各类人群文化和语言需求的服务。
13. 与社区合作，共同设计、实施和评估文化和语言适宜的实践及其成效。
14. 建立文化和语言适宜的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、服务对象群体和社会公众，通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。